TEMA 44 · Cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales. Principales problemas del aparato digestivo. Ostomías. Técnicas y procedimientos

Resumen OPE Enfermería SMS · Semiología y exploración, boca y esófago (disfagia, acalasia, varices, cáusticos, ERGE), estómago (úlcera, HDA, bariátrica), intestino (obstrucción, apendicitis, diverticulitis, EII, CCR), vía biliar, hígado, páncreas, anorrectal, pruebas, ostomías, SNG, enemas y muestras de heces

1. Semiología digestiva

- **Diarrea**: **> 3 deposiciones/día** de menor consistencia; **crónica > 4 semanas**. **Estreñimiento**: **< 3 deposiciones/semana**, heces duras o esfuerzo excesivo.
- **Escala de Bristol** (7 tipos): **1-2 = estreñimiento** (trozos duros); **6-7 = diarrea** (acuosas).

Término	Significado
Hematemesis	Vómito de sangre **roja** o en **posos de café** (digerida): **HDA**. Siempre urgencia
Melena	Heces **negras, brillantes, pegajosas y fétidas** (alquitrán): sangre digerida, **HDA**
Hematoquecia	Sangre roja o «vino tinto» **mezclada** con heces: hemorragia baja (o alta masiva de tránsito rápido)
Rectorragia	Sangre **roja brillante** por el ano, al final de la deposición: hemorroides, fisuras, recto-colon distal
Esteatorrea	Heces **grasas, voluminosas, pálidas, fétidas que flotan**: **malabsorción** (celiaquía, insuficiencia pancreática)
Vómito **fecaloide / bilioso**	Obstrucción intestinal baja / presencia de bilis

- **Ictericia**: bilirrubina **> 2-2,5 mg/dl**; tiñe piel y **escleróticas** (los **carotenos** colorean la piel pero **no la esclerótica**). **Ascitis**: su causa principal es la **cirrosis (80-85%)**.

2. Exploración abdominal

- Orden: **Inspección → Auscultación → Percusión → Palpación** (se ausculta **antes de tocar** para no alterar los ruidos hidroaéreos). Palpación **superficial primero** y luego profunda, dejando la zona dolorosa para el final.
- Ruidos **metálicos** (hiperperistaltismo de lucha) = **obstrucción** inicial; **silencio abdominal** = **íleo paralítico o peritonitis**. Percusión: **timpanismo** (gas) frente a **matidez** (líquido/masa); **matidez cambiante** y **signo de la oleada** = ascitis.
- **Nódulo de la hermana María José** (umbilical) = metástasis (cáncer gástrico); **cabeza de medusa** = hipertensión portal.

Signo	Qué es	Sugiere
Murphy	Se **interrumpe la inspiración** al palpar bajo el reborde costal derecho	**Colecistitis aguda**
McBurney	Dolor en la unión del **tercio externo con los dos tercios internos** de la línea ombligo-EIAS derecha	**Apendicitis**
Blumberg	Dolor a la **descompresión brusca**	**Irritación peritoneal**
Rovsing	Presionar la **FII** provoca dolor en la **FID**	Apendicitis
Psoas / obturador	Flexión del muslo contra resistencia / rotación de la cadera flexionada	Apéndice **retrocecal / pélvico**
Grey Turner / Cullen	Equimosis en **flancos** / **periumbilical**	**Pancreatitis necrohemorrágica**
Courvoisier-Terrier	**Vesícula palpable e indolora** con ictericia	**Cáncer de cabeza de páncreas**
Kehr	Dolor irradiado al **hombro**	Irritación diafragmática

3. Boca y esófago

- **Gingivitis** reversible con higiene; **periodontitis** irreversible (pérdida ósea, movilidad dental). **Parotiditis** (paperas, paramixovirus): complicación **orquitis** en pospúberes; prevención con **triple vírica**. **Sialolitiasis**: sobre todo **submaxilar**; cólico salival **al comer**; hidratación, **sialogogos** (limón) y masaje.
- **Divertículo de Zenker**: por encima del esfínter esofágico superior; halitosis y regurgitación. **Anillo de Schatzki**: esófago distal. **Disfagia lusoria**: compresión por subclavia derecha aberrante.
- **Disfagia orofaríngea** (neurológica: ACV, Parkinson, ELA): precoz, con **tos y aspiración**. **Esofágica**: **mecánica** = primero **sólidos y luego líquidos**, progresiva (tumor, estenosis); **motora** = **sólidos y líquidos desde el inicio** (acalasia). Cribado **EAT-10** y **MECV-V** (método volumen-viscosidad); dieta con **textura adaptada y espesantes**.
- **Acalasia**: el **EEI no se relaja** y falta peristaltismo; disfagia a sólidos y líquidos, regurgitación nocturna. Esofagograma en **«pico de pájaro»**; prueba definitiva **manometría**. Tratamiento: **dilatación neumática**, **miotomía de Heller** (+ fundoplicatura) o **toxina botulínica** (temporal).
- **Varices esofágicas** (hipertensión portal): prevención con **betabloqueante no selectivo (propranolol)**; **ligadura con bandas**; en hemorragia: **terlipresina/octreótide** + endoscopia urgente; si falla, **sonda de Sengstaken-Blakemore** o **TIPS**.
- **Cuerpos extraños**: endoscopia **< 24 h** y **inmediata** si **pila de botón** u objeto punzante (necrosis y perforación en horas).
- **Cáusticos** (lejía, ácidos): **no inducir el vómito, no lavado gástrico, no neutralizar**; asegurar vía aérea; **endoscopia en 24-48 h**; secuela tardía: **estenosis** (y más riesgo de carcinoma).
- **Perforación esofágica**: más frecuente **iatrogénica**; **Boerhaave** = rotura espontánea tras vómitos violentos con **tríada de Mackler** (**vómitos + dolor torácico + enfisema subcutáneo**). **Dieta absoluta**, fluidos, antibióticos, Fowler y cirugía.
- **ERGE**: **pirosis y regurgitación**; IBP; endoscopia si signos de alarma. **Esófago de Barrett** (metaplasia intestinal) = **premaligno** → **adenocarcinoma**. Medidas: **elevar la cabecera**, no acostarse tras comer, comidas poco copiosas, perder peso, evitar tabaco, alcohol, grasas, café y chocolate.
- **Hernia de hiato**: **tipo I por deslizamiento (≈ 90%)**; tipo II **paraesofágica** (riesgo de estrangulación).
- **Cáncer de esófago**: **disfagia progresiva** y pérdida de peso. **Epidermoide** (tercio medio-superior; **alcohol y tabaco**) y **adenocarcinoma** (tercio distal; **Barrett, ERGE, obesidad**).

4. Estómago y duodeno

- **Gastritis aguda**: AINE, alcohol, estrés: úlceras de **Curling (quemados)** y de **Cushing (TCE)**. **Crónica tipo A** autoinmune (fundus-cuerpo, **anemia perniciosa**: B12) y **tipo B por *H. pylori*** (antro; la más frecuente).
- **Úlcera péptica**: ***H. pylori*** (> 70% gástricas y **≈ 95% duodenales**) y **AINE**. El grupo **O** se asocia a úlcera duodenal.

Úlcera **duodenal**	Úlcera **gástrica**
Dolor **2-3 h tras comer** o en ayunas, **despierta de madrugada**	Dolor **precoz (30-60 min)** tras comer
Mejora con la comida y antiácidos	**No mejora o empeora** al comer: anorexia, pérdida de peso
Casi nunca maligniza	**Biopsiar siempre** (descartar cáncer)

- Diagnóstico: **endoscopia** (más sensible que el bario); en jóvenes sin alarma, **test del aliento o antígeno en heces**. Erradicación: **IBP + claritromicina + amoxicilina (o metronidazol) 14 días**.
- Complicaciones: **hemorragia (la más frecuente)**; **perforación** (úlcera duodenal anterior: dolor súbito, **abdomen en tabla**, neumoperitoneo; cierre con **parche de Graham**); penetración (páncreas → dolor dorsal); **obstrucción pilórica** (vómitos tardíos, **alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasemia**).
- **HDA**: origen **por encima del ángulo de Treitz**; causa principal **úlcera péptica**; otras: varices, **Mallory-Weiss** (desgarro tras vómitos). **Urea elevada**. Actuación: **2 vías periféricas gruesas (14-18 G)**, reposición de volemia, monitorización, **endoscopia urgente**, **IBP IV**; escalas **Glasgow-Blatchford** y **Rockall**.
- **Cáncer gástrico**: **adenocarcinoma (≈ 95%)**, **curvatura menor y antro**; factores: *H. pylori*, gastritis atrófica, **ahumados, salazones y nitritos**; **ganglio de Virchow** (supraclavicular **izquierdo**).

- **Obesidad**: **IMC ≥ 30**; **mórbida ≥ 40** (o ≥ 35 con comorbilidad). Cirugía bariátrica: **restrictivas** (banda gástrica, **gastrectomía en manga**, balón intragástrico **6 meses**), malabsortivas y **mixtas** (**bypass gástrico en Y de Roux**, la más frecuente). **Dumping precoz**: vaciamiento rápido → **taquicardia, sudor, dolor cólico, diarrea** (comidas pequeñas, frecuentes, pobres en azúcares simples, **líquidos fuera de las comidas**).

5. Intestino

- **Celiaquía**: gluten (trigo, cebada, centeno); **anti-transglutaminasa IgA** + **biopsia duodenal** (atrofia vellositaria); **dieta sin gluten de por vida**. **Insuficiencia pancreática**: **elastasa fecal baja**; enzimas con las comidas. **Intolerancia a la lactosa**: diarrea osmótica (test de hidrógeno espirado). **Calprotectina fecal** = inflamación intestinal.
- **Síndrome del intestino irritable**: dolor abdominal recurrente que **mejora con la defecación**, cambios del hábito, **sin sangre ni pérdida de peso**; diagnóstico de **exclusión** con **criterios de Roma IV**. Alarma: inicio > 50 años, sangre, anemia, fiebre, síntomas nocturnos.
- **Obstrucción intestinal**: **delgado (≈ 60%) por bridas/adherencias** (después hernias); **grueso (≈ 40%) por cáncer colorrectal**, diverticulitis y **vólvulo de sigma** (ancianos). Clínica: **dolor cólico, vómitos** (precoces si alta; **fecaloides** si baja), **distensión**, **ausencia de gases y heces**. Rx en bipedestación: **niveles hidroaéreos**; **TAC** = prueba más útil. Tratamiento: **dieta absoluta + SNG en aspiración + sueroterapia**; **≈ 90% de las obstrucciones simples por bridas se resuelven con SNG**; cirugía si completa o **estrangulación**. **Íleo paralítico**: postoperatorio, opioides, hipopotasemia.
- **Apendicitis**: dolor **periumbilical que migra a FID**, anorexia, náuseas, febrícula; leucocitosis > 10.000 (**> 18.000 sugiere perforación**); **ecografía** de elección en dudas (apéndice > 6 mm no compresible); en el **embarazo** el punto se desplaza **hacia arriba**. **Apendicectomía** con antibiótico; complicación principal: **perforación**.
- **Diverticulitis**: **sigma (95%)**, dieta pobre en fibra; **«apendicitis izquierda»** (dolor en **FII**, fiebre). **TAC** de elección; **no colonoscopia ni enema opaco en fase aguda** (esperar ≈ 6 semanas). No complicada: dieta absoluta, sueros y antibióticos. Urgente sucia: **operación de Hartmann** (resección + colostomía terminal + cierre del muñón rectal).
- **Peritonitis**: dolor generalizado, **abdomen en tabla**, silencio abdominal, fiebre; **neumoperitoneo** si perforación. Posición en abdomen agudo: **Fowler con rodillas flexionadas** (relaja el abdomen y dirige el exudado al **Douglas**).

	Enfermedad de Crohn	**Colitis ulcerosa**
Localización	**Cualquier tramo de boca a ano** (sobre todo **íleon terminal**); recto respetado; **perianal**	**Solo colon y recto**; empieza **siempre en el recto**
Distribución	**Segmentaria** (zonas sanas intercaladas)	**Continua** ascendente
Profundidad	**Transmural → fístulas, abscesos, estenosis**	**Mucosa** (y submucosa)
Clínica	**Dolor en FID**, diarrea (poco sangrante), pérdida de peso, masa	**Diarrea con sangre y moco**, **tenesmo**, urgencia
Otros	**Empedrado**, **granulomas no caseificantes**; **el tabaco empeora**; ASCA	**Megacolon tóxico (> 6 cm)**; **colangitis esclerosante primaria**; **el tabaco protege**; p-ANCA
Cirugía	**No curativa** (recidiva)	**Proctocolectomía curativa**

- EII: **5-ASA (mesalazina)**, corticoides (inducción, **no mantenimiento**), azatioprina, **anti-TNF**; dieta **sin residuos en brote**. CU con pancolitis > 8-10 años → **colonoscopias de vigilancia**.
- **Cáncer colorrectal**: secuencia **adenoma-carcinoma** (los **vellosos**, más riesgo; hiperplásicos benignos). **Colon derecho → anemia ferropénica** y cansancio; **izquierdo/sigma → cambio del ritmo**, **heces en cinta**, **rectorragia**, obstrucción. Cribado con **TSOH a partir de los 50 años**.
- **Hemorroides**: **internas** (sobre la **línea dentada**, grados **I-IV**: **rectorragia indolora** y prolapso); **externas** (dolor al **trombosarse**). Fibra, agua, **baños de asiento templados**; **ligadura elástica** (II-III); **hemorroidectomía** (IV). **Absceso anal**: dolor **pulsátil** que empeora al sentarse → **drenaje quirúrgico urgente**. **Fístula**: supuración crónica (clasificación de **Parks**); **fistulotomía** o **setón**; la herida debe cerrar **del fondo hacia fuera** (duchas tras cada deposición).

6. Vía biliar, hígado y páncreas

- **Colelitiasis**: **«4F»** (*female, forty, fat, fertile*); cálculos de **colesterol** los más frecuentes. **Cólico biliar** tras comidas grasas, **< 6 h**, sin fiebre. **Ecografía** de elección (sombra acústica). Sintomática → **colecistectomía laparoscópica**.
- **Colecistitis aguda**: **90% litiásica**; dolor en HD **> 6 h**, fiebre, **Murphy +**; eco: pared > 4-5 mm. Dieta absoluta, sueros, analgesia, antibióticos y **colecistectomía precoz** (primera semana). El manual indica **evitar morfina** (espasmo del esfínter de Oddi). Convalecencia: dieta **baja en grasas**.
- **Coledocolitiasis** → **síndrome coledociano**: **ictericia + coluria + acolia**; extracción por **CPRE** (esfinterotomía); complicación más frecuente de la CPRE: **pancreatitis**. **Tubo de Kehr** (en T) tras explorar el colédoco: se **pinza antes de las comidas** (la bilis pasa al duodeno) y se retira tras colangiografía de control.
- **Colangitis**: **tríada de Charcot** = **fiebre con escalofríos + dolor en HD + ictericia**; **péntada de Reynolds** = + **hipotensión + alteración mental** (sepsis grave). Clave: **drenaje biliar urgente (CPRE)** + antibióticos.
- **Cirrosis** (alcohol, VHB/VHC, esteatohepatitis): **arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia**, Dupuytren. **Ascitis**: **restricción de sodio**, **espironolactona ± furosemida**, paracentesis; **control diario de peso y perímetro abdominal**. **Encefalopatía hepática** (amonio): confusión, inversión del sueño, **asterixis (*flapping*)**; desencadenantes: **hemorragia digestiva, infecciones, exceso de proteínas, estreñimiento**; **lactulosa (2-3 deposiciones blandas/día)** y **rifaximina**. Gravedad: **Child-Pugh** (bilirrubina, albúmina, **INR**, ascitis, encefalopatía) y **MELD** (bilirrubina, creatinina, INR; **> 15** → trasplante). **Ecografía cada 6 meses** (hepatocarcinoma).
- **Hepatocarcinoma**: sobre cirrosis; **alfafetoproteína**. El tumor hepático **más frecuente** son las **metástasis**.
- **Pancreatitis aguda**: **litiasis biliar (40-50%)** y **alcohol (30%)**. Dolor epigástrico **en cinturón** hacia la espalda que **alivia inclinándose hacia delante**; vómitos. **Amilasa y lipasa > 3 veces** (**lipasa más específica**); **TAC con contraste a las 48-72 h**. **Dieta absoluta, fluidoterapia intensa** (riesgo de shock por **tercer espacio**: **balance hídrico y diuresis**), analgesia; **nutrición enteral por sonda nasoyeyunal** mejor que parenteral; **no antibiótico profiláctico** rutinario; CPRE si origen biliar.
- **Pancreatitis crónica**: **alcohol (70-80%)**; dolor que alivia en **posición fetal**; **calcificaciones**; **esteatorrea** (elastasa fecal baja) y **diabetes**. **Abstinencia alcohólica**, **enzimas con las comidas**, triglicéridos de cadena media.
- **Cáncer de páncreas**: adenocarcinoma, **cabeza (60-70%)** → **ictericia indolora** con **Courvoisier-Terrier**; cuerpo-cola → dolor en cinturón, caquexia, diabetes de inicio. Marcador **CA 19-9** (seguimiento). **Whipple** (duodenopancreatectomía cefálica): vigilar **glucemia** y la **fístula pancreática** por los drenajes.

7. Pruebas diagnósticas: cuidados clave

Prueba	Cuidado de enfermería
Sangre oculta en heces	Muestras de **3 deposiciones en días distintos**, porciones de **distintas zonas**
Van de Kamer	Cuantifica la **grasa en heces** (esteatorrea)
Bario (tránsito, enema opaco)	Dieta pobre en residuos, laxantes y ayuno; después **hidratar** y vigilar **heces blancas** (evitar impactación)
Gastroscopia	Ayuno desde medianoche, retirar prótesis; después **ayuno hasta recuperar el reflejo nauseoso**
Ecografía abdominal	**Ayuno** (y vejiga llena si es pélvica)
RM	**Contraindicada con marcapasos** o metales
Biopsia hepática	Antes: decúbito supino con la **mano derecha bajo la cabeza**; punción en **apnea tras espiración**. Después: **decúbito lateral derecho ≥ 2 h** (compresión)
Paracentesis	**Vaciar la vejiga** antes; evacuación lenta con control de TA; **> 5 L** → **albúmina IV 6-8 g por litro** extraído
Lavado gástrico	**Decúbito lateral izquierdo** (previene la broncoaspiración); sonda **Faucher**

8. Ostomías

- **Alimentación**: **gastrostomía** (quirúrgica de Stamm/Janeway o endoscópica **PEG**; menos aspiración que la SNG a largo plazo) y **yeyunostomía** (nutrición **continua**, más diarrea). Cuidados PEG: marcar el nivel externo, **lavar con**

30 ml de agua antes y después de alimentación y fármacos, **cabecera > 30°** durante y después, cura diaria con agua y jabón, **girar la sonda** una vez cicatrizado.

	Colostomía	**Ileostomía**
Lado habitual	**Izquierdo** (descendente-sigma)	**Derecho**
Heces	**Formadas** (ascendente: líquidas; transversa: semilíquidas)	**Líquidas** y continuas
Irritación de la piel	Menor	**Muy irritante** (enzimas)
Deshidratación / Na^+, K^+	Riesgo bajo	**Riesgo alto**
Irrigación	**A veces posible** (sigmoidea)	**No irrigable**

- Estoma normal: **rojo brillante, húmedo y protruyente**; un leve sangrado al roce es normal. Alarma: **pálido o negruzco** (isquemia/necrosis), **retracción** (fugas), **prolapso**, **ausencia de débito** (obstrucción), deshidratación.
- **Vaciar la bolsa a 1/3-1/2** de su capacidad; ajustar el recorte **al diámetro del estoma**; proteger la piel periestomal; cambiar el sistema cada 3-7 días (bolsas cerradas: diario). Dieta inicial **baja en residuos**; **más líquidos en ileostomía**. Apoyo ante el **cambio de imagen corporal**.
- **Irrigación por estoma**: **no antes de 7 días** tras la cirugía; dilatar con el **meñique** lubricado e introducir la sonda **≤ 8 cm**, sin forzar.

9. Técnicas

- **Sondaje nasogástrico**: medir **nariz-lóbulo de la oreja-apéndice xifoides**; paciente en **Fowler** con la **cabeza flexionada** al pasar la orofaringe (pedir que trague). **Comprobación**: **pH del aspirado < 5,5** o **radiografía** (la auscultación con aire **no es fiable**). Fijar, lavar para mantener permeable, cambiar de narina en sondajes largos.
- Sondas: **Levin** (1 luz, la más usada); **Salem** (**doble luz**: drenaje + **ventilación** que evita que se adhiera a la mucosa); **Faucher** (gruesa, **lavado gástrico** en intoxicaciones); **Sengstaken-Blakemore** (**3 luces, 2 balones**: aspiración gástrica, balón gástrico de anclaje y balón **esofágico 25-45 mmHg**): **tijeras a pie de cama** para cortar y desinflar si hay dificultad respiratoria; **de nutrición** (silicona/poliuretano con **fiador**, que se retira tras confirmar por radiografía).
- **Contraindicaciones de la SNG**: obstrucción o perforación esofágica, cirugía esofágica/gástrica reciente y **traumatismo facial o fractura de base de cráneo** (→ **vía orogástrica**).
- **Nutrición enteral**: **cabecera 30-45°** durante y **1 h después**; control del **residuo gástrico** previo.
- **Enemas**: **limpieza** (por distensión o irritación); **retención** (**20-30 min**: oleoso, medicamentoso, opaco con bario); **lavativa de Harris** = **carminativo** (expulsar gases). Posición habitual: **Sims (decúbito lateral izquierdo)**.
- **Fecaloma**: lubricar, **dedo índice** con movimientos circulares para fragmentar. Riesgo: **reacción vagal** (bradicardia, palidez, sudor). El manual describe el decúbito lateral **derecho**; la mayoría de protocolos usan Sims (lateral izquierdo).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Exploración: **I → A → P → P** (auscultar antes de palpar).

! Bristol **1-2 estreñimiento**, **6-7 diarrea**; diarrea crónica **> 4 semanas**.

! Melena y posos de café = **HDA** (sobre el **ángulo de Treitz**); urea elevada.

! Murphy = **colecistitis**; Blumberg = **irritación peritoneal**; Rovsing = apendicitis; Courvoisier = **cáncer de páncreas**; Grey Turner/Cullen = **pancreatitis grave**.

! Disfagia mecánica: **sólidos → líquidos**; motora (acalasia): **ambos desde el inicio**; acalasia = **manometría**, «pico de pájaro».

! Cáusticos: **ni vómito, ni lavado, ni neutralizar**. Pila de botón: **endoscopia inmediata**.

! Boerhaave: **vómitos + dolor torácico + enfisema subcutáneo** (Mackler).

! Úlcera **duodenal mejora** al comer; **gástrica empeora** y **siempre se biopsia**.

! Obstrucción por bridas: **SNG + dieta absoluta** (≈ 90% se resuelve).

! Diverticulitis: **TAC**; **no colonoscopia en fase aguda**.

! Crohn: **boca-ano, segmentaria, transmural, fístulas, tabaco empeora**. CU: **recto, continua, mucosa, megacolon, tabaco protege**.

! Charcot: **fiebre + dolor HD + ictericia**; Reynolds añade **hipotensión y confusión**.

! Lactulosa: **2-3 deposiciones blandas/día**.

! Paracentesis > 5 L: **albúmina 6-8 g/L**; antes, **vaciar la vejiga**.

! Biopsia hepática: después **decúbito lateral derecho ≥ 2 h**. Lavado gástrico: **lateral izquierdo**.

! SNG: **pH < 5,5** o **radiografía**; Sengstaken: **tijeras a pie de cama**.

! **Ileostomía** = heces líquidas, piel irritada, **deshidratación**; bolsa a **1/3**.